Fibrilación auricular: la guía ESC 2024, la ACC/AHA 2023 y los ensayos que llegaron después

Basada en la guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología (Van Gelder y colaboradores, Eur Heart J 2024), contrastada con la guía ACC/AHA/ACCP/HRS 2023 (Joglar y colaboradores, Circulation 2024). Se actualiza con los ensayos clínicos publicados después: anticoagulación en riesgo intermedio (SINGLE-AF), suspensión de la anticoagulación tras la ablación (ALONE-AF, OCEAN), cierre de orejuela (CHAMPION-AF, CLOSURE-AF), fibrilación auricular con stent (ADAPT AF-DES, OPTIMA-AF), ablación frente a procedimiento simulado (PVI-SHAM-AF), ablación por campo pulsado (AVANT GUARD, SINGLE SHOT CHAMPION), tamizaje (AMALFI), café (DECAF) y pérdida de peso en mayores (LOSE-AF). Adultos.

Versión 1.0 · 4 de noviembre de 2026 · Equipo editorial de Medicina en Resumen · Cada criterio y cifra verificados contra la fuente original

CHA_2DS_2-VA ≥2
anticoagula (ESC I); con 1 punto, considéralo (IIa). La ESC quitó el sexo del puntaje; la ACC/AHA conserva CHA_2DS_2-VASc con umbrales distintos por sexo, que en la práctica equivalen[1,2]

HR 0.31
primer ensayo en riesgo intermedio (SINGLE-AF, 1,803 pacientes): ACOD frente a no anticoagular redujo el desenlace compuesto de 1.5 % a 0.5 % a 2 años, con muy pocos eventos[3]

24 h vs 48 h
límite para cardiovertir sin 3 semanas de anticoagulación ni ecocardiograma transesofágico: la ESC bajó el corte a 24 h; la ACC/AHA mantiene 48 h[1,2]

LO QUE TIENES QUE SABER

- **El diagnóstico se hace con ECG** (12 derivaciones o registro de una o más derivaciones; ≥30 s en dispositivos, por consenso). Un reloj que solo usa fotopletismografía no basta.[1,2]
- **AF-CARE ordena todo el manejo:** comorbilidades y factores de riesgo, evitar el ictus, reducir síntomas con frecuencia o ritmo, y reevaluar de forma periódica.[1]
- **Anticoagulación:** decide con el puntaje, no con el patrón (paroxística, persistente) ni con el "éxito" de una cardioversión o ablación. Los ACOD son de elección salvo válvula mecánica o estenosis mitral moderada-grave. Los antiagregantes no sustituyen a la anticoagulación.[1,2]
- **No reduzcas la dosis del ACOD fuera de criterios** y no niegues la anticoagulación por un puntaje de sangrado: corrige los factores modificables.[1,2]
- **Frecuencia:** meta laxa (<110 lpm en reposo) si no hay síntomas. Con FEVI ≤40 %, nada de diltiazem ni verapamilo.[1,2]
- **Ritmo:** controlarlo temprano (≤12 meses del diagnóstico) beneficia a pacientes seleccionados; la ablación es de primera línea en la paroxística.[1,2]
- **Lo nuevo (2025–2026):** ACOD útil en riesgo intermedio; suspender la anticoagulación ≥1 año tras ablación exitosa en riesgo moderado es razonable; monoterapia con ACOD después de 12 meses de un stent; el cierre de orejuela tiene resultados opuestos (no inferior frente al ACOD en candidatos a anticoagulación, pero con más ictus isquémico numérico; no inferioridad no demostrada en pacientes de alto riesgo); la ablación no superó a un procedimiento simulado en calidad de vida.[3–10]

1 Definiciones y diagnóstico
2 AF-CARE y factores de riesgo
3 ¿A quién anticoagular?
4 ACOD: elección y dosis
5 Sangrado y reversión
6 Cierre de orejuela
7 FA con enfermedad coronaria
8 Control de frecuencia
9 Cardioversión y control del ritmo
10 Ablación y anticoagulación después
11 Situaciones especiales
12 ESC vs ACC/AHA
13 Lo que estás haciendo mal
14 Casos
15 Consulta rápida y referencias

1 Definiciones y diagnóstico[1,2]

ESC 2024: tipos temporales

- **Primer diagnóstico:** no diagnosticada antes, sin importar síntomas ni duración.
- **Paroxística:** termina sola o con intervención en ≤7 días (la mayoría en <48 h).
- **Persistente:** no se autolimita (corte de 7 días en los ensayos).
- **Persistente de larga duración:** continua ≥12 meses, todavía candidata a control del ritmo.
- **Permanente:** se decide, de forma compartida, no intentar más restaurar el ritmo sinusal.

Los tipos describen episodios, no fisiopatología: reclasifica con el tiempo.[1]

ACC/AHA 2023: estadios

- La FA se entiende como enfermedad progresiva: del paciente **en riesgo** (factores de riesgo) a la **pre-FA** (sustrato auricular), la **FA** (paroxística, persistente, persistente de larga duración o tras ablación exitosa) y la **FA permanente**.
- Los factores de riesgo se manejan en todos los estadios.
- Una persistente que con tratamiento se vuelve paroxística sigue siendo persistente.
- Términos obsoletos: la ACC retira "crónica", "aislada" (*lone*) y "valvular/no valvular"; la ESC, "valvular".

- **FA clínica vs subclínica:** la clínica está documentada por ECG, con o sin síntomas. La subclínica (o AHRE, episodios de frecuencia auricular alta) la detecta un dispositivo implantado o portátil y requiere revisión visual de los electrogramas; progresa a FA clínica en 6–9 % al año.[1,2]
- **Estudio inicial:** historia y síntomas (escala mEHRA), ECG, biometría hemática, función renal, electrolitos, pruebas hepáticas, glucosa o HbA1c, función tiroidea; ecocardiograma transtorácico si guía decisiones (ESC I/C), sin retrasar la anticoagulación.[1]
- **No busques de rutina** isquemia, SCA ni tromboembolia pulmonar como causa de la FA si no hay datos clínicos que lo sugieran (ACC).[2]

2 AF-CARE y factores de riesgo[1,2,13–15]

C · Comorbilidades
HTA, IC, diabetes, obesidad, alcohol, ejercicio, apnea del sueño.

A · Evitar el ictus
Puntaje, ACOD, factores de sangrado modificables.

R · Reducir síntomas
Frecuencia y ritmo: fármacos, cardioversión, ablación.

E · Evaluar y reevaluar
A los 6 meses y luego al menos cada año.

MEDIDA	ESC 2024	ACC/AHA 2023	COMENTARIO
Pérdida de peso ≥10 % (sobrepeso u obesidad)	I/B	1/B-R (IMC >27)	LOSE-AF (n = 118, 60–85 años, FA persistente): perder 9.7 % del peso no mejoró síntomas ni carga de FA a 8 meses.[15]
Ejercicio	Programa personalizado I/B	210 min/sem moderado-vigoroso 1/B-R	La ACC da la dosis.
Alcohol	≤3 bebidas/semana I/B	Minimizar o eliminar si se busca ritmo 1/B-R	Coinciden.
Café	Sin recomendación	Abstenerse no previene episodios (3: sin beneficio)	DECAF (n = 200, tras cardioversión): ~1 taza/día se asoció a menos recurrencia que la abstinencia (47 % vs 64 %; HR 0.61). No prohíbas el café.[14]
HTA	I/B; meta 120–129/70–79	1/B-NR	Más laxa si hay fragilidad o ≥85 años.[1]
IC	iSGLT2 en cualquier FEVI I/A; diurético si congestión I/C	FA + IC: control del ritmo 2a	La euvolemia facilita controlar la frecuencia.[1]
Apnea del sueño	Manejo IIb/B; tamizar solo con cuestionarios III/B	Tamizar 2b/B-NR	Beneficio del tratamiento incierto.
Tabaco y diabetes	Diabetes I/C	Dejar de fumar 1/B-NR	—

3 ¿A quién anticoagular?[1–3]

CHA_2DS_2-VA (ESC 2024)	PUNTOS	NOTA
C Insuficiencia cardiaca (síntomas o signos, cualquier FEVI, o FEVI ≤40 % asintomática)	1	El sexo femenino ya no suma: es un modificador que depende de la edad. CHA_2DS_2-VASc (ACC/AHA) suma 1 por sexo femenino; por eso sus umbrales son ≥2 en hombres y ≥3 en mujeres, equivalentes a CHA_2DS_2-VA ≥2. Otros modificadores: cáncer, ERC, troponina o BNP elevados, aurícula izquierda dilatada.[1,2]
H Hipertensión (>140/90 en 2 ocasiones o en tratamiento)	1	
A Edad ≥75 años	2	
D Diabetes (tipo 1 o 2)	1	
S Ictus, AIT o tromboembolia arterial previos	2	
V Enfermedad vascular (coronaria, arterial periférica, placa aórtica compleja)	1	
A Edad 65–74 años	1	

SITUACIÓN	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Riesgo alto	CHA_2DS_2-VA ≥2: anticoagular I/C (anticoagulación en riesgo elevado I/A)	Riesgo ≥2 %/año (CHA_2DS_2-VASc ≥2 H / ≥3 M): 1/A
Riesgo intermedio	CHA_2DS_2-VA = 1: considerar IIa/C	1 H / 2 M (1–<2 %/año): razonable 2a/A; usar modificadores si hay duda
Siempre	Miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis cardiaca, sin importar el puntaje I/B	Solo en texto para miocardiopatía hipertrófica
Otros puntajes	Solo herramientas validadas localmente	ATRIA o GARFIELD-AF aceptables
Patrón temporal	No decide III/B	No decide 1/B-R
Antiagregantes en lugar de ACO	III/A	3: daño

SINGLE-AF (NEJM 2026): EL PRIMER ENSAYO EN RIESGO INTERMEDIO

- **Diseño:** abierto, 18 centros de Corea; 1,803 pacientes con CHA_2DS_2-VASc 1 (hombres) o 2 (mujeres); edad media 60 años, 24 % mujeres, 72 % paroxística. ACOD (apixabán 5 mg c/12 h o rivaroxabán 20 mg/d) frente a no anticoagular.[3]
- **Resultado a 2 años:** ictus, embolia, sangrado mayor o muerte CV en 0.5 % vs 1.5 % (HR 0.31; IC 95 % 0.10–0.94). Ictus 3 vs 10. Sangrado mayor 3 vs 4; hemorragia intracraneal 2 vs 1.[3]
- **Lectura:** respalda la recomendación IIa/2a que antes no tenía ensayo propio. Con solo 17 eventos, población coreana joven y diseño abierto, el efecto es impreciso: ofrécelo en decisión compartida, no lo impongas.[3]

FA SUBCLÍNICA (DETECTADA POR DISPOSITIVO)

- **ESC:** ACOD en riesgo alto, excluyendo alto riesgo hemorrágico, IIb/B. ARTESiA: apixabán redujo ictus o embolia (HR 0.63) con más sangrado mayor (HR 1.36); NOAH (edoxabán) se detuvo sin beneficio y con más muerte o sangrado.[1]
- **ACC/AHA** (previa a esos ensayos) gradúa por duración: ≥24 h y CHA_2DS_2-VASc ≥2, 2a; 5 min a 24 h y ≥3, 2b; <5 min, no anticoagular.[2]

ICTUS PESE A ANTICOAGULACIÓN

- Busca causas no cardioembólicas, revisa dosis y adherencia (IIa/B).[1]
- No agregues antiagregante ni cambies de ACOD o a AVK sin una indicación concreta (III/B).[1]
- Tras un ictus, el ACOD temprano (ELAN, TIMING) no fue inferior al tardío.[1]

4 ACOD: elección y dosis[1,2]

- **ACOD sobre AVK** (ESC I/A; ACC 1/A), excepto **válvula mecánica** o **estenosis mitral moderada-grave**: ahí, AVK. Bioprótesis, TAVI, insuficiencia mitral y otras valvulopatías: ACOD.[1,2]
- **AVK:** INR 2.0–3.0; si el tiempo en rango es <70 %, cambia a ACOD (ESC I/B). Excepción: ≥75 años, estable con AVK y polifarmacia, mantener AVK es aceptable (IIb/B).[1]
- **Al iniciar el ACOD, suspende el antiagregante** en la mayoría (salvo indicación coronaria reciente; sección 7).[1]

ACOD	DOSIS PLENA	REDUCCIÓN (ESC 2024)	DOSIS REDUCIDA	DIFERENCIAS EN LA ACC/AHA (ETIQUETA DE EE. UU.)
Apixabán	5 mg c/12 h	2 de 3: edad ≥80 · peso ≤60 kg · creatinina ≥133 µmol/L (≥1.5 mg/dL)	2.5 mg c/12 h	Igual. En diálisis o depuración <15: warfarina o apixabán (2b).
Rivaroxabán	20 mg/d	Depuración de creatinina 15–49 mL/min	15 mg/d	15 mg/d con depuración ≤50 (en diálisis, datos limitados; la recomendación 2b solo nombra warfarina o apixabán).
Edoxabán	60 mg/d	Cualquiera: depuración 15–50 · peso ≤60 kg · ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol	30 mg/d	Contraindicado con depuración >95 mL/min (menor eficacia).
Dabigatrán	150 mg c/12 h	Obligada: ≥80 años o verapamilo. Individualizar: 75–80 años, depuración 30–50, gastritis o reflujo, otro riesgo hemorrágico. Contraindicado con TFGe <30	110 mg c/12 h	Sin 110 mg en EE. UU.: 75 mg c/12 h con depuración 15–30; contraindicado <15.

Las dos guías llaman "no basada en evidencia" a la dosis reducida sin criterios (ESC III/B; ACC 3: daño): aumenta el ictus sin bajar el sangrado. ERC: la ESC no tiene recomendación con clase; la ACC/AHA indica ACOD o warfarina en ERC 3 (1/B-R) y en ERC 4 (2a).[1,2]

5 Sangrado y reversión[1,2]

RIESGO DE SANGRADO

- **Evalúa y corrige los factores modificables** (ESC I/B; ACC 1/B-NR): HTA no controlada, antiagregantes o AINE, alcohol, INR lábil, interacciones (CYP3A4, glicoproteína P), esteroides; IBP si el riesgo gastrointestinal es alto.[1,2]
- **No uses un puntaje de sangrado** (HAS-BLED u otro) para negar o retirar la anticoagulación (ESC III/B; ACC 3: sin beneficio). Discriminan mal y comparten factores con el ictus.[1,2]
- Contraindicaciones absolutas, raras: tumor intracraneal primario, hemorragia intracraneal por angiopatía amiloide.[1]

SANGRADO ACTIVO

- Suspende el anticoagulante e interviene la fuente (ESC I/C).[1]
- **Dabigatrán:** idarucizumab (ACC 1; ESC IIa/B). **Anti-Xa:** andexanet (ACC 1; ESC IIa/B) o concentrado de complejo protrombínico de 4 factores (ACC 1; la ESC lo menciona sin clase). **AVK:** concentrado de complejo protrombínico + vitamina K IV (ACC 1/A; ESC IIa/C).[1,2]
- Carbón activado si la última toma fue hace <2–4 h.[1]
- **Reiniciar después:** no reiniciar se asocia a más infarto, ictus y muerte; tras sangrado gastrointestinal mayor, reiniciar es razonable (ACC 2b).[1,2]

6 Cierre de orejuela izquierda[1,2,6,7]

ESCENARIO	ESC 2024	ACC/AHA 2023	ENSAYOS 2026
Percutáneo, contraindicación a la anticoagulación	IIb/C	2a/B-NR (CHA_2DS_2-VASc ≥2)	**CHAMPION-AF** (3,000 candidatos a anticoagulación; 72 años; CHA_2DS_2-VASc 3.5; solo Watchman FLX): no inferior al ACOD en muerte CV, ictus o embolia a 3 años (5.7 % vs 4.8 %; margen absoluto 4.8 puntos), pero con más ictus isquémico o embolia (3.2 % vs 2.2 %; ictus total HR 1.46, IC 0.94–2.27). Menos sangrado no relacionado con el procedimiento (10.9 % vs 19.0 %; HR 0.55), a expensas del no mayor; el sangrado mayor total, incluido el del procedimiento, fue similar (5.9 % vs 6.4 %). Derrame pericárdico con intervención 0.7 %; trombo en el dispositivo 4.8 %. **CLOSURE-AF** (888 de alto riesgo de ictus y de sangrado; 78 años, CHA_2DS_2-VASc 5.2): **no fue no inferior** al tratamiento médico (16.8 vs 13.3 eventos/100 pacientes-año) ni redujo el sangrado mayor (70 vs 61 pacientes; 7.4 vs 6.2/100 pacientes-año); 5.7 % de complicaciones a 7 días.[6,7]
Percutáneo por preferencia (alto riesgo hemorrágico)	—	2b/B-R	
Quirúrgico durante cirugía cardiaca, además de la anticoagulación	I/B	1/A	LAAOS III: HR 0.67 para ictus isquémico o embolia sistémica.[1,2]

Lectura editorial: CHAMPION-AF usó un margen absoluto amplio con pocos eventos (los propios autores lo señalan), un solo dispositivo, pocos pacientes con CHA_2DS_2-VASc ≥5 y financiamiento del fabricante; el beneficio en sangrado fue sobre todo no mayor y el ictus isquémico fue numéricamente mayor. CLOSURE-AF, en el perfil "clásico" del cierre, fue negativo. Sigue siendo una opción cuando la anticoagulación está realmente contraindicada, no la alternativa por defecto.[6,7]

7 FA con enfermedad coronaria[1,2,8,9]

Tras ICP o SCA
ACOD (no AVK) + clopidogrel. Aspirina solo peri-ICP: ≤1 semana (ESC I/A); 1–4 semanas (ACC 1/A). Triple terapia hasta 1 mes si el riesgo isquémico supera al hemorrágico (ESC IIa).[1,2]

Doble terapia
ACOD + clopidogrel hasta **12 meses en SCA** y **6 meses en coronariopatía crónica** (ESC I/A). Si preocupa más el sangrado: rivaroxabán 15 mg o dabigatrán 110 mg (IIa/B).[1]

Después de 12 meses
ACOD solo. Antiagregante adicional >12 meses en enfermedad coronaria estable: no (ESC III/B; ACC: monoterapia 1/B-R).[1,2]

ENSAYO	POBLACIÓN Y COMPARACIÓN	RESULTADO
ADAPT AF-DES (NEJM 2026)	960 pacientes coreanos con stent farmacoactivo ≥1 año antes (mediana 33 meses); ACOD solo vs ACOD + clopidogrel	Eventos clínicos netos a 12 meses 9.6 % vs 17.2 % (HR 0.54), por menos sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante (5.2 % vs 13.2 %; HR 0.38), sin señal isquémica. Confirma la monoterapia después del año.[8]
OPTIMA-AF (Lancet 2026)	1,079 pacientes japoneses con ICP electiva guiada por imagen (94 % coronariopatía crónica); doble terapia (ACOD + P2Y12) 1 vs 12 meses	Sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante 4.5 % vs 8.8 % (HR 0.50), a expensas del no mayor; eficacia no inferior (5.4 % vs 4.3 %), pero con margen amplio y mortalidad numéricamente mayor (4.1 % vs 2.8 %). Lectura: opción en ICP electiva cuando preocupa el sangrado (el ensayo no seleccionó por riesgo hemorrágico); no extrapolar a infarto.[9]

8 Control de frecuencia[1,2]

- **Meta:** laxa, <110 lpm en reposo (ESC IIa/B; ACC <100–110, 2a); más estricta si persisten síntomas o se sospecha taquicardiomiopatía.[1,2]

- **FEVI >40 %:** betabloqueador, diltiazem, verapamilo o digoxina (ESC I/B). **FEVI ≤40 %:** betabloqueador y/o digoxina; diltiazem y verapamilo contraindicados (ACC 3: daño con FEVI <40 % a largo plazo y con disfunción moderada-grave en agudo).[1,2]
- **Digoxina:** primera línea en la ESC (I/B); segunda línea en la ACC (2a), con niveles <1.2 ng/mL.[1,2]
- **En el enfermo agudo,** trata primero o en paralelo la causa (sepsis, sobrecarga de volumen, choque). Betabloqueador o calcioantagonista actúan más rápido que la digoxina.[1]
- **Refractaria:** ablación del nodo AV con marcapasos (IIa/B). Con resincronización: ESC IIa/B en FA permanente con síntomas graves y ≥1 hospitalización por IC; ACC 2a/B-R con FEVI <50 %.[1,2]

FÁRMACO	IV (AGUDO)	VO (MANTENIMIENTO)
Metoprolol	2.5–5 mg en 2 min; máximo 15 mg	25–100 mg c/12 h
Esmolol	500 µg/kg en 1 min → 50–300 µg/kg/min	—
Landiolol	100 µg/kg opcional → 10–40 µg/kg/min (1–10 en críticos o choque séptico)	—
Bisoprolol · carvedilol	—	1.25–20 mg/d · 3.125–50 mg c/12 h
Diltiazem (FEVI >40 %)	0.25 mg/kg en 5 min → 5–15 mg/h	60 mg c/8 h hasta 360 mg/d
Verapamilo (FEVI >40 %)	2.5–10 mg en 5 min	40 mg c/12 h hasta 480 mg/d
Digoxina	0.5 mg (0.75–1.5 mg/24 h en dosis divididas)	0.0625–0.25 mg/d; ajustar en ERC
Amiodarona (último recurso)	300 mg en 30–60 min → 900–1,200 mg/24 h por vía central	—

Todos los fármacos que frenan el nodo AV (y la amiodarona IV) están contraindicados en la FA preexcitada. La dronedarona no sirve para controlar la frecuencia en la FA permanente (aumenta IC, ictus y muerte CV). Dosis de la tabla 12 de la ESC.[1]

9 Cardioversión y control del ritmo[1,2]

TEMA	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Inestabilidad hemodinámica	Cardioversión eléctrica urgente (ESC I/C; ACC 1/C-LD). En sepsis o choque la recaída inmediata es frecuente; la amiodarona es segunda línea y actúa tarde.	
Sin anticoagulación ni ETE	**FA >24 h o de inicio incierto: no cardiovertir** (III/C)	**FA ≥48 h:** 3 semanas de anticoagulación o imagen (1/B-R); <48 h con CHA_2DS_2-VASc ≥2, imagen "puede considerarse" (2b)
Antes de una cardioversión programada	≥3 semanas de anticoagulación terapéutica o ETE sin trombo (ESC I/B). ACOD preferidos (ESC I/A). Si hay trombo: ESC, anticoagular ≥4 semanas y repetir el ETE (IIa/C); ACC, 3–6 semanas y repetir la imagen (1/C-LD).	
Después	Anticoagulación ≥4 semanas en todos (ESC I/B; ACC 1/B-NR); a largo plazo según el puntaje, sin importar el ritmo. Opcional solo si no hay factores de riesgo y la FA duró <24 h (ESC).	
"Esperar y ver"	≤48 h sin compromiso hemodinámico IIa/B: 55–66 % convierte solo en 24 h	—
Control del ritmo temprano	≤12 meses del diagnóstico en pacientes seleccionados con riesgo tromboembólico (ESC IIa/B; ACC 2a/B-R): EAST-AFNET 4 redujo muerte CV, ictus y hospitalización.	

FÁRMACO	DOSIS (ESC)	CUÁNDO Y CUÁNDO NO
Flecainida	VO 200–300 mg · IV 1–2 mg/kg en 10 min	Inicio reciente, sin cardiopatía estructural, HVI grave ni coronariopatía (ESC I/A). Asocia un frenador del nodo AV (evita flutter 1:1). Evitar con depuración <35 o Brugada.[1]
Propafenona	VO 450–600 mg · IV 1.5–2 mg/kg en 10 min	Mismas condiciones que flecainida. "Pastilla en el bolsillo" con flecainida o propafenona, probada antes en el hospital (ESC IIa/B; ACC 2a/A).[1,2]
Vernakalant	3 mg/kg en 10 min (máximo 339 mg) → 2 mg/kg	No con PAS <100, SCA <1 mes, NYHA III–IV, QT largo o estenosis aórtica grave (ESC I/A). La ACC no lo incluye.[1]
Amiodarona	300 mg IV en 30–60 min → 900–1,200 mg/24 h	Con HVI grave, IC con FEVI reducida o coronariopatía; convierte tarde (ESC I/A; ACC 2a/A).[1,2]
Ibutilida	1 mg IV en 10 min (0.01 mg/kg si <60 kg)	Riesgo de torsades: monitoreo ≥4 h (ACC 2a/A con FEVI ≥40 %).[1,2]

- **No hagas cardioversión farmacológica** con disfunción sinusal, trastorno de conducción AV o QTc >500 ms sin valoración (ESC III/C).[1]
- **Antiarrítmicos a largo plazo:** elegir por seguridad, no por eficacia (reducen recurrencias 20–50 %). Amiodarona en IC con FEVI reducida; dronedarona en IC con FEVI conservada o ligeramente reducida, cardiopatía isquémica o valvular; flecainida o propafenona sin cardiopatía estructural (ESC I/A; ACC 2a). Sotalol IIb. Ninguno con trastorno de conducción avanzado sin marcapasos.[1,2]

10 Ablación y anticoagulación después[1,2,4,5,10–12]

INDICACIÓN	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Tras fallo o intolerancia a antiarrítmicos	I/A	1/A
Primera línea en paroxística	I/A	1/A (jóvenes, pocas comorbilidades); 2a en otros
Primera línea en persistente	IIb/C	2a/B-R
IC con FEVI reducida	I/B si probable taquicardiomiopatía; IIa/B en el resto	1/A con tratamiento médico óptimo
Anticoagulación periablación	Iniciar ≥3 semanas antes (I/C); no interrumpir (I/A); mantener ≥2 meses después (I/C); luego según el puntaje, no según el "éxito"	No interrumpir; mantener ≥3 meses después (1/B-NR); luego según el puntaje

LO NUEVO EN ABLACIÓN

- **PVI-SHAM-AF** (Lancet 2026; 262 pacientes; doble ciego): la ablación redujo la FA en Holter de 7 días (21 % vs 41 %), pero la calidad de vida a 6 meses no fue significativamente mejor que con un procedimiento simulado (diferencia 2.6 puntos; p = 0.36). Parte de la mejoría tras la ablación es inespecífica.[10]
- **AVANT GUARD** (NEJM 2026): en persistente sin tratamiento previo, la ablación por campo pulsado superó a los antiarrítmicos (éxito 56 % vs 30 %; HR de fracaso 0.46), con 5.1 % de eventos graves del procedimiento.[11]
- **SINGLE SHOT CHAMPION** (NEJM 2025; 210 pacientes con monitor implantable): en paroxística, campo pulsado no inferior y además superior a crioablación (recurrencia 37.1 % vs 50.7 %; P = 0.046 para superioridad).[12]

¿SUSPENDER LA ANTICOAGULACIÓN TRAS UNA ABLACIÓN EXITOSA?

- **Guías:** no; se decide por el puntaje.[1,2]
- **ALONE-AF** (JAMA 2025; 840 pacientes coreanos sin recurrencia ≥1 año; CHA_2DS_2-VASc 2.1): suspender vs continuar el ACOD redujo ictus, embolia o sangrado mayor a 2 años (0.3 % vs 2.2 %), por menos sangrado; ictus isquémico 0.3 % vs 0.8 %.[4]
- **OCEAN** (NEJM 2026; 1,284; ≥1 año sin recurrencia en Holter; CHA_2DS_2-VASc 2.2): rivaroxabán 15 mg vs aspirina, sin diferencia en ictus, embolia o nuevo infarto embólico encubierto ≥15 mm en RM (0.8 % vs 1.4 %; p = 0.28). Sangrado mayor o fatal 1.6 % vs 0.6 % (sin diferencia significativa), pero más sangrado no mayor clínicamente relevante (5.5 % vs 1.6 %).[5]
- **Lectura:** en riesgo moderado, sin recurrencia documentada ≥1 año, suspender el ACOD es una opción razonable en decisión compartida. ALONE-AF lo comparó con no dar nada; OCEAN, con aspirina. La evidencia es escasa con ictus previo o puntaje alto.[4,5]

11 Situaciones especiales[1,2,13]

SITUACIÓN	MANEJO
FA preexcitada (QRS ancho, irregular, muy rápida)	Cardioversión eléctrica si hay compromiso. Evita los frenadores del nodo AV y la amiodarona; ibutilida o flecainida (propafenona con cautela).[1]
Sepsis y enfermedad aguda ("FA inducida por desencadenante")	Trata la causa: hasta 83 % recupera el ritmo en 48 h, pero la recurrencia es alta: 42–68 % a 5 años tras una enfermedad médica aguda (ACC). En la fase aguda de la sepsis el beneficio de anticoagular es incierto (ACC 2b). Tras corregir el desencadenante, anticoagulación a largo plazo si el riesgo es alto (ESC IIa/C); avísale al paciente del riesgo de recurrencia (ACC 1).[1,2]
Posoperatoria	Cirugía cardiaca 30–50 %; no cardiaca 5–30 %. Prevención: amiodarona perioperatoria en cirugía cardiaca (ESC I/A; ACC 2a con betabloqueador); no suspendas betabloqueadores; betabloqueador profiláctico de rutina en cirugía no cardiaca, no (ESC III/B). Anticoagulación: a largo plazo si el riesgo es alto (ESC IIa/B, incluida la no cardiaca) frente a 60 días y reevaluar tras cirugía cardiaca (ACC 2a).[1,2]
Hipertiroidismo	Mide TSH en toda FA nueva. Betabloqueador (propranolol reduce la conversión de T4 a T3). ACC: anticoagular hasta lograr eutiroidismo y ritmo sinusal si el puntaje lo indica (1/B-NR); la ESC no tiene recomendación con clase. Amiodarona solo si no hay alternativa.[1,2]
Embarazo	Cardioversión eléctrica si hay inestabilidad o preexcitación. Betabloqueador β1-selectivo (no atenolol); digoxina si no basta. Heparina de bajo peso molecular, o AVK fuera del primer trimestre y antes de la semana 36, si el riesgo es alto. ACOD no recomendados.[1,2]
Tamizaje	ESC: buscar FA en ≥65 años (I/C) y tamizaje prolongado con ECG en ≥75, o ≥65 con factores de riesgo (IIa/B). ACC: sin recomendación poblacional. AMALFI (JAMA 2025; 5,040 personas ≥65 años con CHA_2DS_2-VASc ≥3 en hombres o ≥4 en mujeres): un parche de ECG de 14 días aumentó poco el diagnóstico a 2.5 años (6.8 % vs 5.4 %); el ictus, desenlace exploratorio, no cambió (2.7 % vs 2.5 %).[1,2,13]

12 ESC 2024 vs ACC/AHA 2023: dónde difieren[1,2]

TEMA	ESC 2024	ACC/AHA 2023
Clasificación	Tipos temporales	4 estadios de enfermedad progresiva
Puntaje	CHA_2DS_2-VA (sin sexo); ≥2 I/C, 1 IIa/C	CHA_2DS_2-VASc, ATRIA o GARFIELD-AF; ≥2 %/año 1/A; 1–2 %/año 2a/A; sexo = modificador
FA subclínica	ACOD IIb/B en riesgo alto (tras ARTESiA y NOAH)	Por duración: ≥24 h 2a; 5 min–24 h 2b; <5 min no
Dosis de ACOD	Dabigatrán 110 mg; contraindicado con TFGe <30	Dabigatrán 75 mg con depuración 15–30; edoxabán contraindicado >95; diálisis: warfarina o apixabán 2b
Cierre de orejuela percutáneo	IIb/C	2a/B-NR si contraindicación; 2b por preferencia
Reversión	Antídotos IIa/B	Idarucizumab, andexanet o CCP 1
Digoxina	Primera línea I/B	Segunda línea 2a; magnesio IV 2a/A
Ablación	Persistente primera línea IIb/C; IC-FEr I/B o IIa/B	Persistente primera línea 2a/B-R; IC-FEr 1/A
Cardioversión sin anticoagular ni ETE	Corte de 24 h; "esperar y ver" IIa/B	Corte de 48 h
Antiarrítmicos	Cardioversión farmacológica y mantenimiento I/A	2a (procainamida 2b)
FA posoperatoria	Amiodarona preventiva I/A; ACO a largo plazo IIa/B	Betabloqueador o amiodarona 2a; tras cirugía cardiaca, ACO 60 días y reevaluar 2a
Tamizaje e hipertiroidismo	Tamizaje ≥65 I/C; hipertiroidismo sin recomendación con clase	Sin tamizaje poblacional; hipertiroidismo: ACO hasta eutiroidismo 1/B-NR

13 Lo que estás haciendo mal

- **Dar aspirina o clopidogrel "en lugar de" anticoagulante.** No previenen el ictus y sí sangran.[1,2]
- **Reducir la dosis del ACOD "por si acaso"** en el anciano o con ERC leve sin cumplir criterios.[1,2]
- **Negar la anticoagulación por un HAS-BLED alto** en vez de corregir los factores modificables.[1,2]
- **No anticoagular la paroxística "porque es poca".** El patrón no decide.[1,2]
- **Cardiovertir una FA de inicio incierto o >24 h (ESC) sin 3 semanas de anticoagulación ni ETE,** o no anticoagular las 4 semanas posteriores.[1]
- **Suspender la anticoagulación tras una cardioversión o ablación "exitosa" solo por el éxito,** sin valorar el puntaje ni la evidencia nueva.[1,4,5]
- **Diltiazem o verapamilo con FEVI ≤40 %,** o frenadores del nodo AV y amiodarona en la FA preexcitada.[1,2]
- **Mantener triple terapia larga** o un antiagregante con el ACOD más allá de 12 meses en coronariopatía estable.[1,2,8]
- **Prohibir el café** a todo paciente con FA.[14]

14 Casos

Caso 1

Mujer de 72 años con HTA y diabetes tipo 2; FA paroxística en Holter. Pesa 58 kg; creatinina 1.6 mg/dL.

Respuesta. CHA_2DS_2-VA = 3 (HTA, diabetes, 65–74 años; el sexo ya no suma): anticoagular (ESC I). Con CHA_2DS_2-VASc = 4 (mujer), la ACC llega a lo mismo. Apixabán: cumple 2 de 3 criterios (≤60 kg y creatinina ≥1.5 mg/dL) → 2.5 mg c/12 h. Que sea paroxística no cambia la decisión; la aspirina no es alternativa.[1,2]

Caso 2

Hombre de 55 años sin cardiopatía, palpitaciones de inicio claro hace 8 h, estable. CHA_2DS_2-VA 0.

Respuesta. Opciones: "esperar y ver" hasta 48 h con control de frecuencia (ESC IIa/B), o cardioversión farmacológica (flecainida o propafenona IV, I/A) o eléctrica. Con <24 h no requiere ETE; sin factores de riesgo, la anticoagulación posterior es opcional. Si con "esperar y ver" la FA pasa de 24 h, ya no cardiovertir sin 3 semanas de anticoagulación o ETE (III/C). Si recurre, ofrece "pastilla en el bolsillo" probada antes en el hospital.[1]

Caso 3

Paciente en UCI por neumonía con choque séptico; FA a 150 lpm, PAM 60 mmHg, FEVI 35 %.

Respuesta. Trata la sepsis y el volumen primero. Cardioversión eléctrica si la inestabilidad se atribuye a la FA (I/C), sabiendo que la recaída es frecuente. Para frecuencia: landiolol (1–10 µg/kg/min), amiodarona o digoxina IV (ESC IIb/B en inestabilidad o FEVI muy reducida); nada de diltiazem ni verapamilo. Al alta, si el puntaje lo indica, anticoagulación a largo plazo (ESC IIa/C): la recurrencia es alta.[1,2]

Caso 4

Hombre de 70 años con FA en apixabán, infarto sin elevación del ST con ICP no complicada.

Respuesta. Aspirina solo peri-ICP (≤1 semana), luego apixabán a dosis plena + clopidogrel hasta 12 meses (I/A), y después apixabán solo: ADAPT AF-DES respalda la monoterapia tras el año. No cambies a AVK. IBP si el riesgo gastrointestinal es alto. OPTIMA-AF (1 mes de doble terapia) se probó en ICP electiva, no en infarto.[1,8,9]

15 Consulta rápida

Diagnóstico	ECG (≥30 s en dispositivos). Laboratorio con TSH, función renal y hepática; eco transtorácico si guía decisiones.
Anticoagular	CHA_2DS_2-VA ≥2 sí; 1 considerar (SINGLE-AF lo apoya). Miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis: siempre. Patrón irrelevante. Sin antiagregantes en su lugar.
ACOD	Apixabán 5 mg c/12 h (2.5 si 2 de: ≥80 años, ≤60 kg, Cr ≥1.5) · rivaroxabán 20 mg/d (15 con depuración 15–49) · edoxabán 60 mg/d (30 si depuración 15–50, ≤60 kg o interacciones) · dabigatrán 150 mg c/12 h (110 si ≥80 años o verapamilo). AVK si válvula mecánica o estenosis mitral moderada-grave.
Sangrado	Corrige factores modificables; no niegues por puntaje. Idarucizumab · andexanet o CCP4F · CCP + vitamina K.
Frecuencia	<110 lpm. FEVI >40: BB, diltiazem, verapamilo o digoxina. FEVI ≤40: BB y/o digoxina. Preexcitada: nada de frenadores del nodo AV.
Cardioversión	Inestable: eléctrica. Sin anticoagulación ni ETE: solo si <24 h (ESC) o <48 h (ACC). Después, anticoagular ≥4 semanas en todos.
Ritmo	Temprano (≤12 meses) en seleccionados. Ablación primera línea en paroxística; en IC con FEVI reducida, considerarla.
Coronariopatía	Aspirina ≤1 semana → ACOD + clopidogrel 12 meses (SCA) o 6 meses (crónica) → ACOD solo.
Tras ablación exitosa	Guías: según puntaje. ALONE-AF y OCEAN: suspender es razonable en riesgo moderado, ≥1 año sin recurrencia, en decisión compartida.
Estilo de vida	Peso −10 %, ejercicio, alcohol ≤3 bebidas/semana, PA 120–129/70–79. El café no se prohíbe.

Superíndices: **1** = guía ESC 2024 (Van Gelder, Eur Heart J 2024); **2** = guía ACC/AHA/ACCP/HRS 2023 (Joglar, Circulation 2024); **3** = SINGLE-AF; **4** = ALONE-AF; **5** = OCEAN; **6** = CHAMPION-AF; **7** = CLOSURE-AF; **8** = ADAPT AF-DES; **9** = OPTIMA-AF; **10** = PVI-SHAM-AF; **11** = AVANT GUARD; **12** = SINGLE SHOT CHAMPION; **13** = AMALFI; **14** = DECAF; **15** = LOSE-AF. Las clases se citan como I/IIa/IIb/III (ESC) y 1/2a/2b/3 (ACC/AHA). Los recuadros "Lo que estás haciendo mal", los casos y la consulta rápida son material educativo propio basado en estas fuentes.

SOBRE ESTA GUÍA EN RESUMEN

Medicina en Resumen condensa guías y artículos recientes para médicos. Cuando las fuentes difieren, lo señalamos y mostramos las variantes. No sustituye el criterio del médico tratante ni los protocolos locales. Más guías y videos en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen

Referencias

1. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. doi:10.1093/eurheartj/ehae176
2. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149(1):e1–e156. doi:10.1161/CIR.0000000000001193
3. Kim D, Lee YS, Shim J, et al. Anticoagulation for atrial fibrillation with intermediate stroke risk. N Engl J Med 2026 (publicado en línea el 28 de agosto de 2026). doi:10.1056/NEJMoa2607978
4. Kim D, Shim J, Choi EK, et al. Long-term anticoagulation discontinuation after catheter ablation for atrial fibrillation: the ALONE-AF randomized clinical trial. JAMA 2025;334(14):1246–1254. doi:10.1001/jama.2025.14679
5. Verma A, Birnie DH, Jiang C, et al. Antithrombotic therapy after successful catheter ablation for atrial fibrillation. N Engl J Med (publicado en línea el 8 de noviembre de 2025). doi:10.1056/NEJMoa2509688
6. Doshi SK, Kar S, Nair DG, et al. Left atrial appendage closure or anticoagulation for atrial fibrillation. N Engl J Med 2026;394(21):2083–2094. doi:10.1056/NEJMoa2517213
7. Landmesser U, Skurk C, Kirchhof P, et al. Left atrial appendage closure or medical therapy in atrial fibrillation. N Engl J Med 2026 (publicado en línea el 18 de marzo de 2026). doi:10.1056/NEJMoa2513310
8. Lee SJ, Yu HT, Lee YJ, et al. Therapy for atrial fibrillation in patients with drug-eluting stents. N Engl J Med (publicado en línea el 8 de noviembre de 2025). doi:10.1056/NEJMoa2512091
9. Sotomi Y, Kozuma K, Higuchi Y, et al. 1-month versus 12-month dual antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention in patients with atrial fibrillation (OPTIMA-AF). Lancet 2026;408:440–452. doi:10.1016/S0140-6736(26)00665-3
10. Wachter R, Haag P, Uhe T, et al. Catheter ablation for symptomatic atrial fibrillation (PVI-SHAM-AF): a randomised, double-blind, sham-controlled, multicentre trial. Lancet 2026;408:999–1009. doi:10.1016/S0140-6736(26)01558-8
11. Wazni OM, Chun KRJ, Nair DG, et al. Pulsed field ablation as initial therapy for persistent atrial fibrillation. N Engl J Med 2026;394(24):2407–2418. doi:10.1056/NEJMoa2600929
12. Reichlin T, Kueffer T, Badertscher P, et al. Pulsed field or cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation. N Engl J Med 2025;392(15):1497–1507. doi:10.1056/NEJMoa2502280
13. Wijesurendra R, Pessoa-Amorim G, Buck G, et al. Remote screening for asymptomatic atrial fibrillation: the AMALFI randomized clinical trial. JAMA 2025;334(15):1349–1357. doi:10.1001/jama.2025.15440
14. Wong CX, Cheung CC, Montenegro G, et al. Caffeinated coffee consumption or abstinence to reduce atrial fibrillation: the DECAF randomized clinical trial. JAMA 2026;335(4):317–325. doi:10.1001/jama.2025.21056
15. Sclafani M, Spartera M, Esmati Y, et al. Weight loss in older patients with persistent atrial fibrillation: the LOSE-AF randomized clinical trial. JAMA 2026;336(3):205–214. doi:10.1001/jama.2026.5787